



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : شيماء هاشم عبد الوهاب ناجي

العنوان : الدرب الاحمر

الحي / المدينة : الدرب الاحمر

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 01-10-2026

رقم التليفون : 01286233176

رقم البطاقة : 27910260100902

العمر (تاريخ الميلاد) : 26-10-1979 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: شيماء هاشم عبد الوهاب ناجي National ID: 27910260100902	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bone scintigraphy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
وزارة الداخلية
مديرية الأحوال المدنية

شعبه
مكتم عداله طبى ناجى
بني الشرايى - الحمراء - القاهرة
الترب الأحمر

٢٧٩١٠٢٦٠١٠٠٩٠٢

٢٧٩١٠٢٦٠١٠٠٩٠٢

JM2027575

٢٧٩١٠٢٦٠١٠٠٩٠٢

مديرية
الأحوال المدنية



٢٠٢٢/٠٨ ٢٧٩١:٢٦٠١٠٠٩٠٢
بلون عيل
التي
مطبعة
متروحة
محمد عبدالمقصود التوتى عرايى
الطبعة سنوية حتى ٢٠٢٩/٠٨/٠٤



25/02/2024, 10:04

code 42 - Name_A MDT form Hammal - Name_E MDT form Hammal



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : شيماء هاشم عبدالوهاب ناجي

Sex:

3- Medical number:

Female

83186927

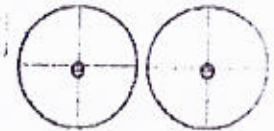
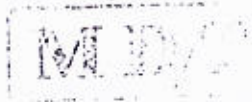
Old Med :

Old Med :

469-2024

2-ID number: 27910280100902

Patient Age : 44 Y



Family history

Family History
+ve

Phone

Phone

01281233176

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
POST OPERATIVE

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

25/02/2024

Co morbidity

Co morbidity

Menopausal
statusMenopausal Status
POSTMENOPAUSAL

Initial STAGE

INITIAL STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX
IDCER
8/8PR
7/8Her 2 Neu
3

SISH

KI67
80

BX COMMENT:

ER COMMENT:

PR COMMENT:

Her 2 Neu COMMENT:

SISH COMMENT:

T
2N
0M
0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

It breast mass wide local excision IDC GII

DCIS high grade

no lymphovascular invasion

free surgical margin

LN 0/20

pt received 1 cycle AC

U/S:free

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

PORT ,3 cycles AC then 4 TXT and herceptin SQ For 6 months then AI

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

PSYCHIATRIC

Nutrition

NUTRITION

Name: شيماء هاشم عبد الوهاب ناجي			
MR. : 2425			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها			
The patient was discussed at the multidisciplinary team (MDT) in February 2024 for a breast mass that had undergone wide local excision. Pathology revealed invasive ductal carcinoma, grade II, with a component of high-grade ductal carcinoma in situ; there was no lymphovascular invasion and surgical margins were free. Twenty lymph nodes were examined and were negative (LN 0/20). The patient subsequently received one cycle of AC chemotherapy. The MDT recommended postoperative radiotherapy, followed by three additional cycles of AC, then four cycles of targeted therapy (TXT) with trastuzumab, and continuation of herceptin subcutaneously. Adjuvant endocrine therapy with an aromatase inhibitor (Femara) and supportive care were planned for three months, with the next clinic visit scheduled for 20 September 2026. The patient has completed 1 cycle of AC.			
تحريراً في ,			
التاريخ :		19-09-2026	
الوقت :		نهى سعيد علي محمد	
الطبيب المعالج :			
يعتمد ,			

259



Patient Result PATHOLOGY

Patient's Name : شيفاء فاشم عبد الوهاب ناجي Sex : F
Patient's No : 100246895 Birth Date : 26-10-1979 Patient's Type : نسائي
Request No : 3169503 Request Date : 21-01-2024 Time : 11:41:37 AM
Department : A045 حراحة ٢ - نساء
Referred By Prof.Dr. :

Report Number : 259-24

REPORT Date : 27-01-2024

Specimen : I-Left breast mass II-Axillary clearance

GROSS

- Mammary tissue 15x10x4cm marked by stitches. On opening, a firm greyish white mass 2.5x2cm is seen at 0.5 cm from nearest superficial margin. Sections were processed from margins: 1-Lateral 2-Medial 3-Superior 4-Inferior 5-Deep 6-Superficial and 7-B Mass 8-Paraffin from the mass.
II-Single fibrofatty tissue fragment 10x10cm with multiple foci, largest 1.0cm, processed in 5 blocks

MICROSCOPIC & DIAGNOSIS

- Left breast mass; wide local excision
- Single mass 2.5cm at 0.5cm from nearest (superficial) margin.
- Infiltrating duct carcinoma grade 2.
- Ductal carcinoma in situ: High grade 20%.
- No lymphovascular invasion.
- High TILs (tumoral infiltrating lymphocytes)
- All resection margins: Free
- Axillary lymph nodes: Twenty lymph nodes free of malignancy (0/20).
- Pathological stage: pT2 N0 Mx.

ADDENDUM:

IMMUNOHISTOCHEMICAL RESULTS:

- ER: Positive nuclear staining in 100% of cells (Allred score 8/8).
- PR: Positive intense nuclear staining in 60% of cells (Allred score 7/8).
- Her-2neu: Intense complete membranous staining in 30% of neoplastic cells and moderate staining in 60% of cells (3+)
- Ki-67: 80% (High proliferative index).

PROF. DR/FATEN WAGDI

M.N.

شارع الطائفة لعبد بن بجوار كلية تجارة الهياضية - القاهرة - مصر

El Khalifa El Maamoun Abbassiam, Area Past Code 11586, Cairo, Egypt

ASR
American Systems
REGISTRAR

ANAB
ACCREDITED
NATIONAL
CERTIFICATION BODY

Ain Shams University, Specialized Hospital
ISO 9001:2015 Certificate No. 014

Patient: Shimaa HANem Abdel Wahhab

Date: 9/3/2024

^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired information: *skeletal surveying to detect multiple lesions.*

Technique: Anterior and posterior whole-body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP:

Report:

- Heterogenous radiotracer uptake is seen over the spine more pronounced at the lower dorsal, lumbar vertebrae likely degenerative changes.
- Osteoarthritic changes are seen at both shoulders, knees joints
- No active osseous lesions could be seen all over the surveyed skeleton,
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

no definite hot spot that could account for osseous metastatic deposits.

Thanks for referral

Nuclear Medicine Unit
DR. Sherein Mahdy, M.D

Dr/ Mohamed, Emam



Echo - Cardiographic Report

Name: Shaimaa Hashem Abdelwahab

Sex : F

Date: 5 \ 2 \ 2024

M-Mode Measurements:

LVEDd:	53	37-54 mm	EF:	69%	55-75%
LVESd:	32	22-40 mm	FS:	39%	27-45%
IVSd:	10	06-11 mm	Ao:	28	20-37 mm
PWtd:	9	07-11 mm	LA:	35	19-40 mm
RV:	22	07-23 mm	Other:		

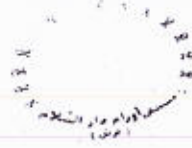
Comments:

- Normal LV internal dimensions with normal septal wall thickness and Normal LV systolic function.
- Impaired diastolic function (grade 1)
- No RWMA at rest(However CAD cannot be excluded)
- Normal Aortic root dimension
- Normal LA dimension
- Mild aortic valve sclerosis with Mild AR
- Normal RV and RA dimensions with Mild TR, ESPAP = 38 mmHg.
- No intracardiac masses, vegetations or thrombi could be detected by TTE.
- Intact Cardiac septae(IAS & IVS)
- Normal pericardium with no effusion.
- Normal flow across descending aorta

Conclusion:

Normal LV systolic function
Sclerotic aortic valve with mild AR

Dr. Ashraf Alamir, MD
Consultant of Cardiology



Total DLP: 10.5 mGy

Patient Name: Shaimaa Hashem Abd Al Wahab	Date : 11/02/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 469/2024	46820

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Status post left BCS showing operative bed distortion nodularity and skin thickening with no sizable gross residual neoplastic masses.
- Bilateral basal atelectatic bands.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers.
- *Minimal pericardial effusion.*
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. No focal lesions or biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Normal urinary bladder with no filling defects or



Total DLP (mGy.cm):

Patient Name: Shaimaa Hashem Abd Al Wahab	Date : 11/02/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 469/2024	46820

- No abdominal or pelvic masses or collections.
- D8 lytic lesion with vertical striation likely hemangioma.

Opinion:

- *Status post left BCS showing operative bed distortion nodularity and skin thickening with no sizable gross residual neoplastic masses.*
- *No sizable pulmonary, hepatic or osseous metastasis.*

Dr. Ali Saber, MSc.

Dr. Amr Farouk, M.D.



Patient Name: Shaimaa Hashem Abd Al Wahab	Date : 21/10/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 469/2024	Pat. ID: 46820

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Post left CBS

Findings:

Left breast.

- Heterogeneously dense parenchyma. (ACR C)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- **UOQ architectural distortion with central radiolucency and associated macrocalcifications owing to the operative bed**
- **Ultrasound demonstrated post-operative changes in the outer central region (at the operative scar) in form of parenchymal distortion, skin thickening and diffuse interstitial edema.**
- Normal nipple/areola complex.
- Clear left axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Right breast.

- Heterogeneously dense parenchyma. (ACR C)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

- ***Left breast (BIRADS 2): post operative changes***
- ***Right breast (BIRADS 1): Normal study.***

Recommendation:-

- ***For annual follow up.***

Dr farah elshobaky

Signature Farah
AM 11:53 2025/10/21

Patient Name: Shaimaa Hashem Abd Al Wahab	Date : 21/08/2025
Exam : MRI BRAIN WITH CONTRAST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 469/2024	Pat. ID: 46820

MRI OF THE BRAIN WITH CONTRAST

Findings:

- No cerebral parenchymal areas of abnormal signal intensity.
- no evidence of enhancing cerebral or meningeal lesions.
- Normal size and configuration of the ventricular system with no evidence of deformity or displacement.
- No cerebellum or brain stem areas of abnormal signal intensity
- No mid line shift.
- Examined PNS are unremarkable apart from deviated nasal septum to the left..

OPINION:

- No evidence of metastasis. .
- No recent ischemic insult.

Dr. Reham Khedr (MD)

Signature Reeham.Khader
27/08/2025 1:07 AM